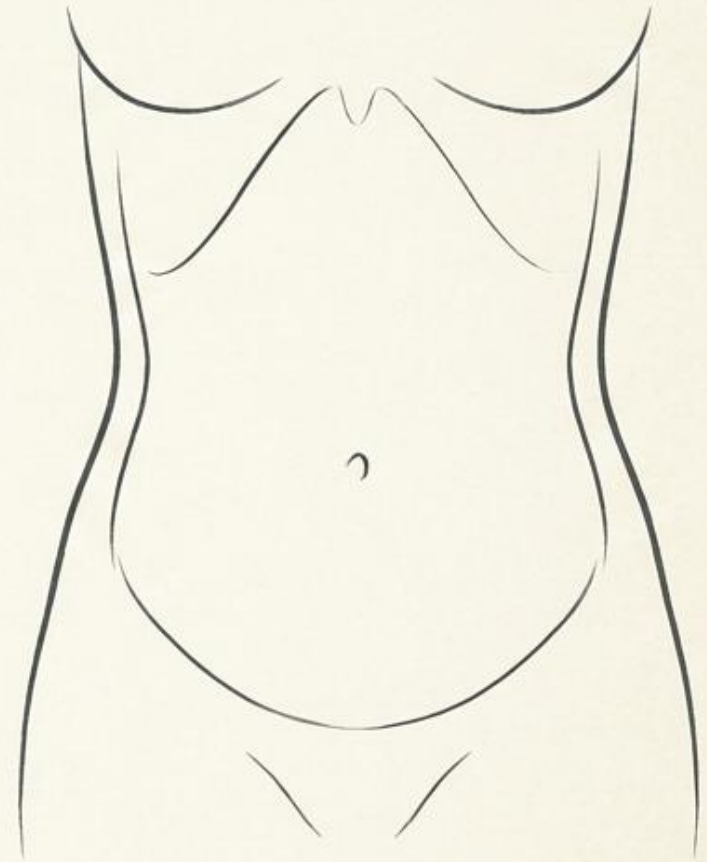


Chapitre 7 — Cavités Abdominale et Péritonéale

Anatomie, Physiologie et
Applications Cliniques ROP

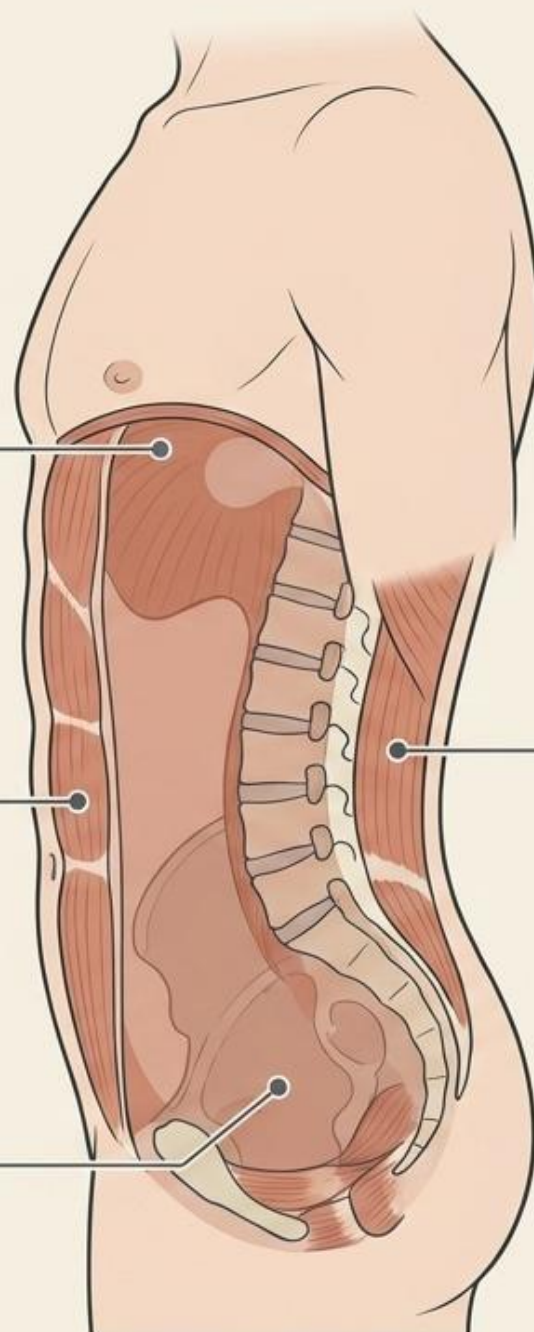


Le Contenant Abdominal : Frontières et Pressions

Céphaliquement :
Le diaphragme

Ventralement & Latéralement :
Muscles abdominaux
(transverse, obliques, grands droits)

Caudalement :
Fosses iliaques internes / Bassin



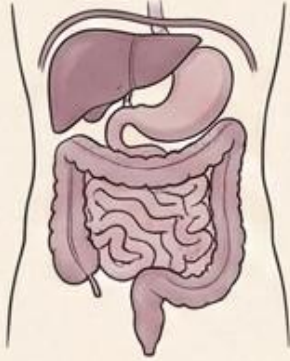
Dynamique des Pressions

Les viscères sont soumis à une pression abdominale positive globale. Bien que séparés, ils sont directement influencés par les variations de pression de la cavité thoracique.

Dorsalement :
Mur ostéo-musculaire
(carré des lombes,
(carré des lombes, psoas)

Note : Les fascias interposés (thoraco-abdominal, transversalis) participent aux contraintes mécaniques influençant la cavité.

Les Trois Espaces Viscéraux (Le Contenu)



Cavité intra-péritonéale

Contenu : Estomac, foie, voies biliaires, intestin grêle.

Caractéristique : Viscères enveloppés par le péritoine (péritonisés) et portés par un méso.



Cavité rétro-péritonéale

Contenu :
Côlon ascendant/descendant, loge rénale, duodénum, pancréas.

Caractéristique : Accolement secondaire à la face postérieure du péritoine pariétal. Maintien par pressions locales et rapports fasciaux.



Cavité sous-péritonéale

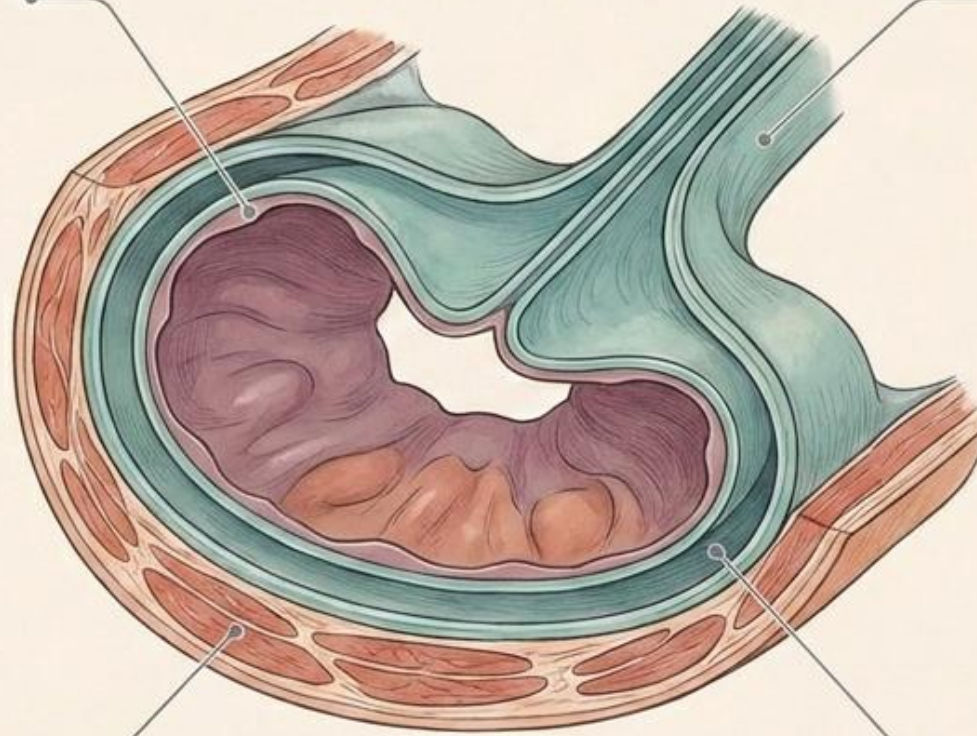
Contenu : Viscères de la cavité pelvienne.

Caractéristique : Séparés de l'abdomen par la réflexion du péritoine au-dessus d'eux. Mobilité influencée par les tensions péritonéales.

L'Architecture du Péritoine

Feuillet Viscéral : Revêtement
mésothélial translucide
adhérant au viscère.

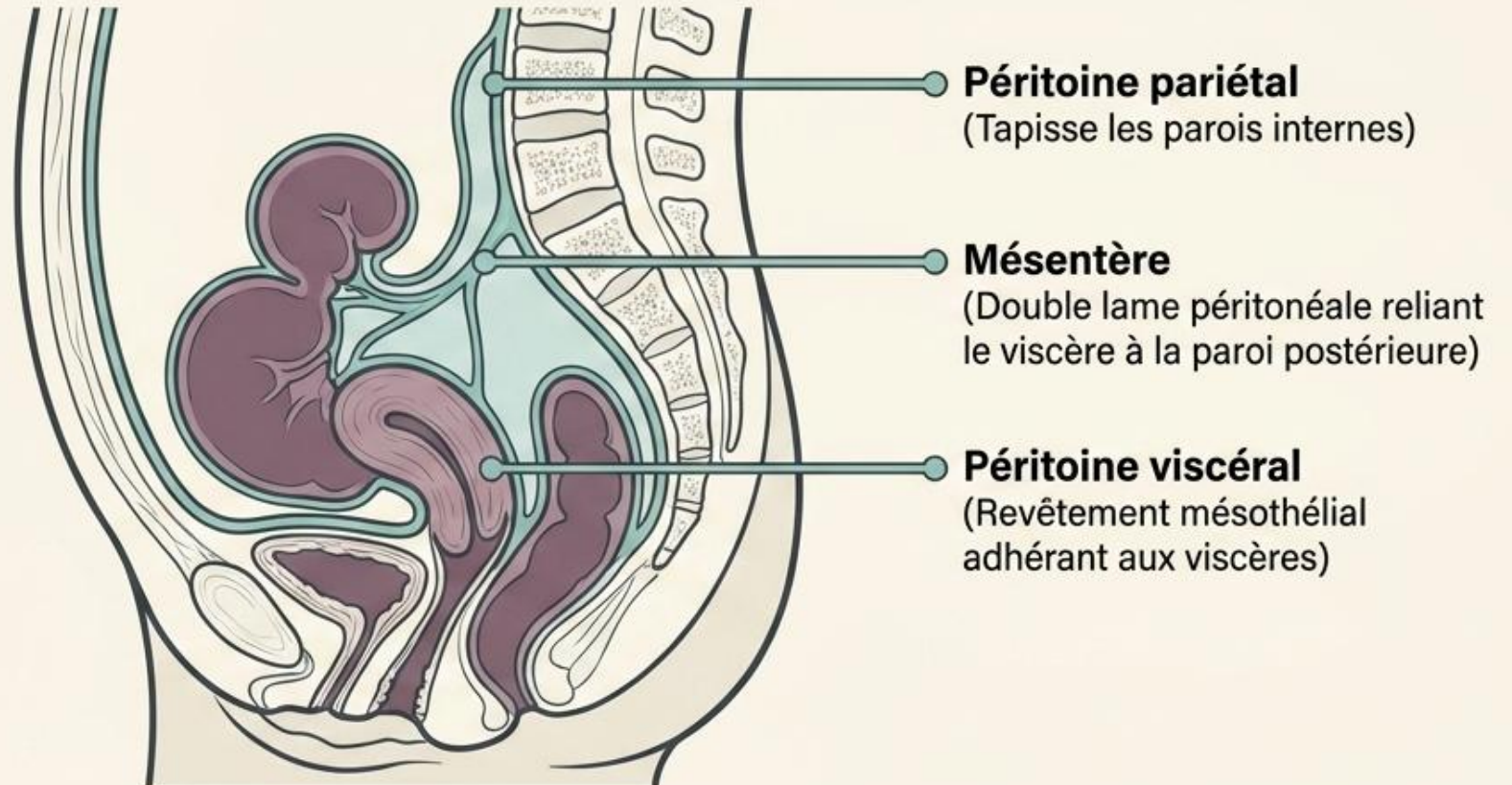
Mésentère : Double
lame péritonéale reliant
le viscère à la paroi.



Feuillet Pariétal : Tissu
conjonctif au contact des
parois lombo-iliaques.

Cavité Péritonéale : Espace
virtuel situé entre les deux
feuilletts, contenant le liquide
péritonéal.

Architecture du Péritoine : Une Séreuse Complexe



Cavité péritonéale

Espace virtuel contenant le liquide péritonéal. Le **feuillet pariétal** se réfléchit au niveau du hile pour devenir le **feuillet viscéral**.

Organisation en double feuillet créant un espace de glissement interviscéral.

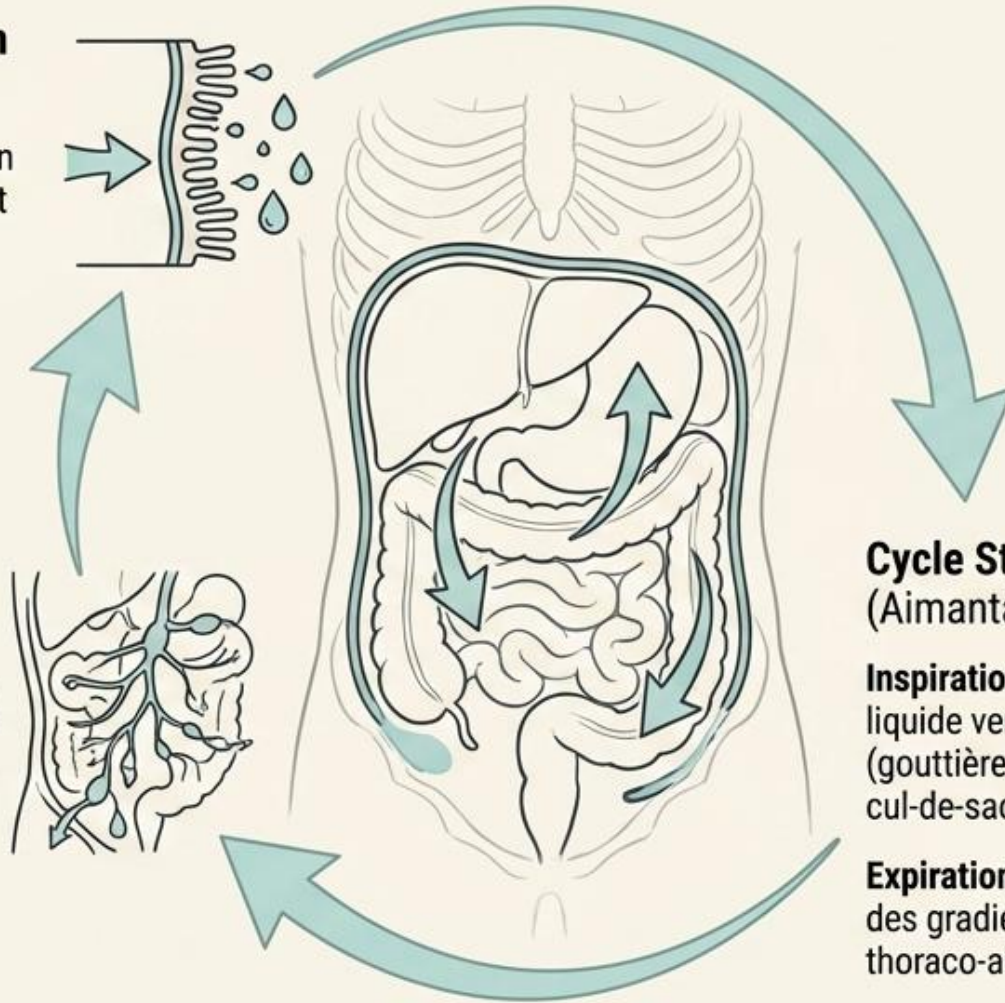
L'Écosystème Liquidien et la Dynamique Péritonéale

Cycle Step 1 : Sécrétion (Mésothélium)

Production de liquide riche en eau, électrolytes, protéines et macrophages. Les microvillosités augmentent massivement la surface d'échange.

Cycle Step 3 : Réabsorption (Drainage)

Élimination des déchets via le péritoine et le vaste réseau lymphatique intestinal.



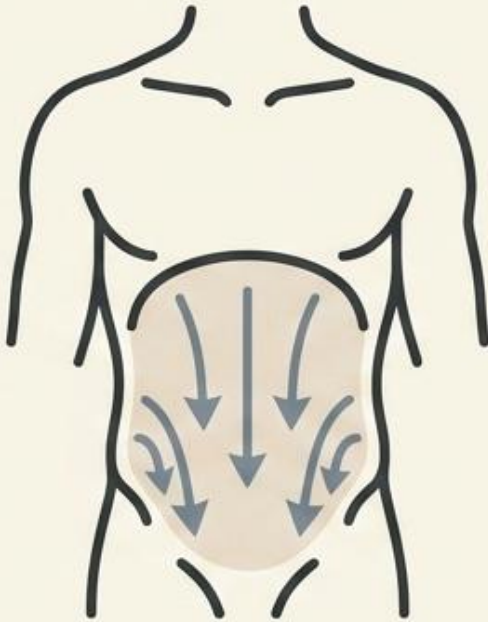
Cycle Step 2 : Circulation (Aimantation Diaphragmatique)

Inspiration: Redistribution du liquide vers les parties déclives (gouttière pariéto-colique droite, cul-de-sac de Douglas).

Expiration: Remontée sous l'effet des gradients de pression thoraco-abdominaux.

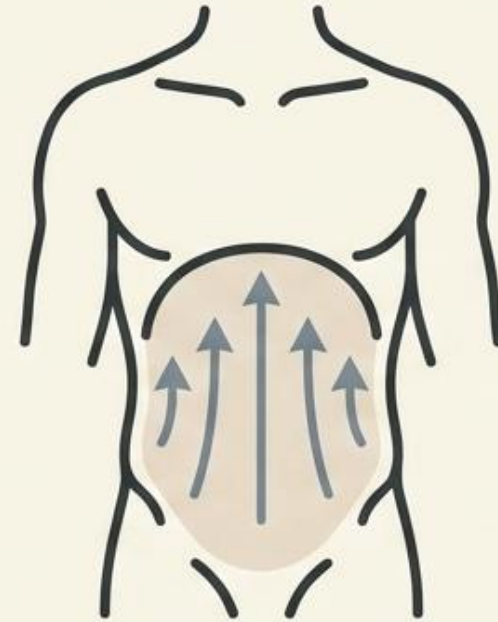
Dynamique des Fluides : L'Aimantation Diaphragmatique

Inspiration (Poussée)



La descente diaphragmatique redistribue le liquide péritonéal vers les zones déclives (gouttières pariéto-coliques, cul-de-sac de Douglas).

Expiration (Traction)



La remontée crée un gradient de pression thoraco-abdominal, aspirant les fluides vers le haut.

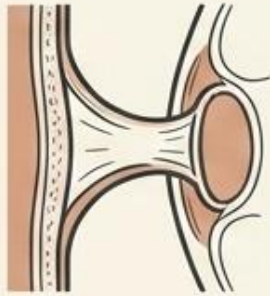
L'Effet Turgor

Le liquide contient des facteurs de surface (surfactants) qui facilitent le glissement interviscéral et participent à la cohésion des feuillets.

Perspective ROP

Cette dynamique de pression (« Aimantation diaphragmatique ») est le moteur mécanique de la mobilité viscérale rythmique. Évaluer l'aimantation, c'est évaluer la vitalité tissulaire.

Les Amarres Péritonéales : Typologie des Replis



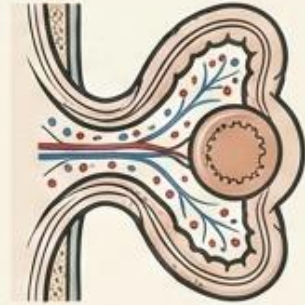
1. Les Ligaments

Duplicatures simples reliant un viscère à la paroi ou à une autre structure.
Rôle de maintien mécanique.



2. Les Omentums (Épiploons)

Lames à double feuillet reliant deux viscères entre eux (ex: grand omentum gastro-colique). Souvent infiltrés de graisse, fonction de protection immunitaire.



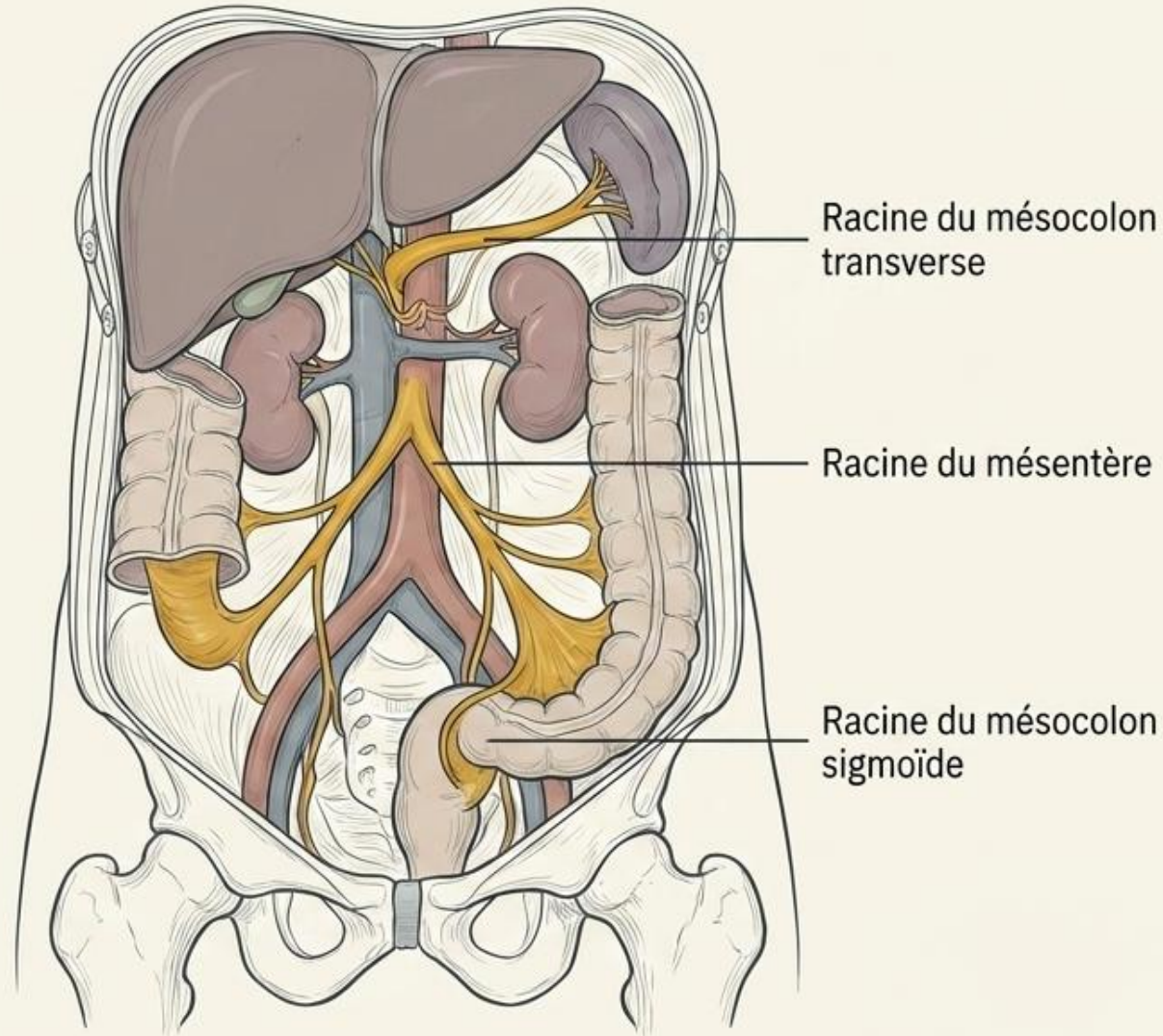
3. Les Mésos

Double lame reliant un viscère « péritonisé » à la paroi postérieure.
Rôle vital : Ce sont les voies de passage exclusives des pédicules vasculo-nerveux.

Point Clé

Les mésos ne sont pas de simples haubans mécaniques, mais les « cordons ombilicaux » nourriciers des viscères abdominaux.

Les Racines et les Mésos : Les Points d'Ancrage



Mécanique Structurale:

Les mésos relient les viscères au péritoine pariétal postérieur. Ils véhiculent le pédicule vasculo-nerveux.

Le Compartimentage:

La racine du mésocolon transverse divise l'espace en étages sus-mésocolique (estomac, foie, rate) et infra-mésocolique (grêle, côlon).

Intérêt Clinique ROP:

Les racines des mésos sont des zones réflexes majeures. Leur sollicitation accompagne la régulation fonctionnelle viscérale.

Accessibilité:

Le côlon transverse et le sigmoïde étant très mobiles, le praticien ROP privilégie l'action sur leurs extrémités et leurs racines, plus stables et perceptibles.

Carrefours, Hiatus et Tensions Mécaniques

Les zones de moindre résistance et le risque de fixations péritonéales.



1. Jonction Thoracique (Hiatus Œsophagien)

Risque: Reflux gastro-œsophagien et hernies hiatales.

Mécanisme: Altération des pressions entre la cavité thoracique et abdominale.



2. Jonctions Pelviennes et Fémorales

Canal Inguinal: Béance de l'orifice profond (hernies inguinales).

Anneau Fémoral: Hernies fémorales sous le ligament inguinal.

Panel Synthèse

Fixations et Adhérences

- Traumatismes ou chirurgies (ex: appendicectomie) créent des brides cicatricielles.
- Ces adhérences contraignent vaisseaux et nerfs, provoquent des ptoses par tiraillement des mésos, ou altèrent la fonction locale (ex: infertilité par gêne tubo-ovarienne).
- Action ROP: Équilibrer les tensions péritonéales autour de ces carrefours.

L'Axe Vasculaire Principal

Alerte Clinique: Palpation de l'Aorte

Entre le pancréas et l'ombilic. Calibre normal : 2-3 cm.
Si largeur perçue ~4-5 cm (pulsation expansive) : orientation médicale impérative (risque d'anévrisme).

Tronc Cœliaque (L1) → Intestin Antérieur

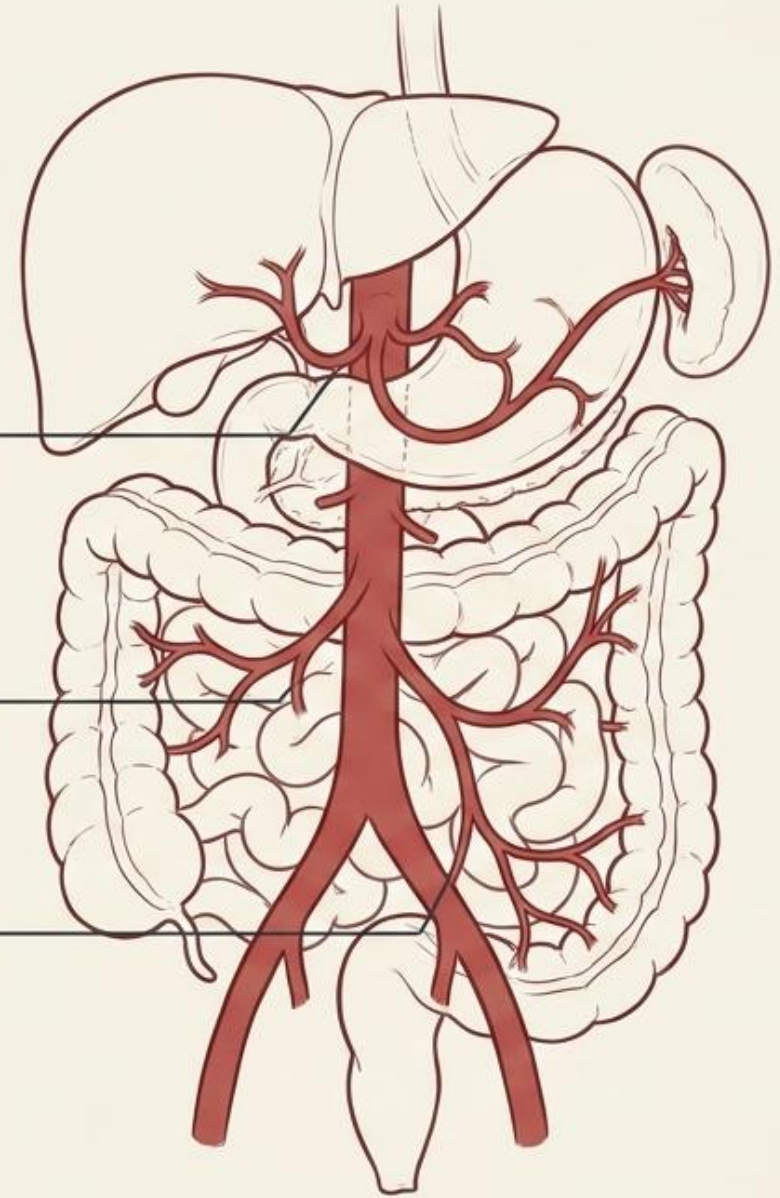
- Artère gastrique gauche (petite courbure).
- Artère hépatique commune.
- Artère splénique (témoin ROP de l'activité de la rate).

Artère Mésentérique Supérieure (L1) → Intestin Moyen

Vascularise l'intestin grêle et le côlon droit.
Pouls près de la jonction duodéno-jéjunale.

Artère Mésentérique Inférieure (L3) → Intestin Postérieur

Vascularise le côlon gauche.
Pouls difficile à percevoir.



Note drainage: Le sang veineux, chargé en nutriments, rejoint le foie via le système porte.

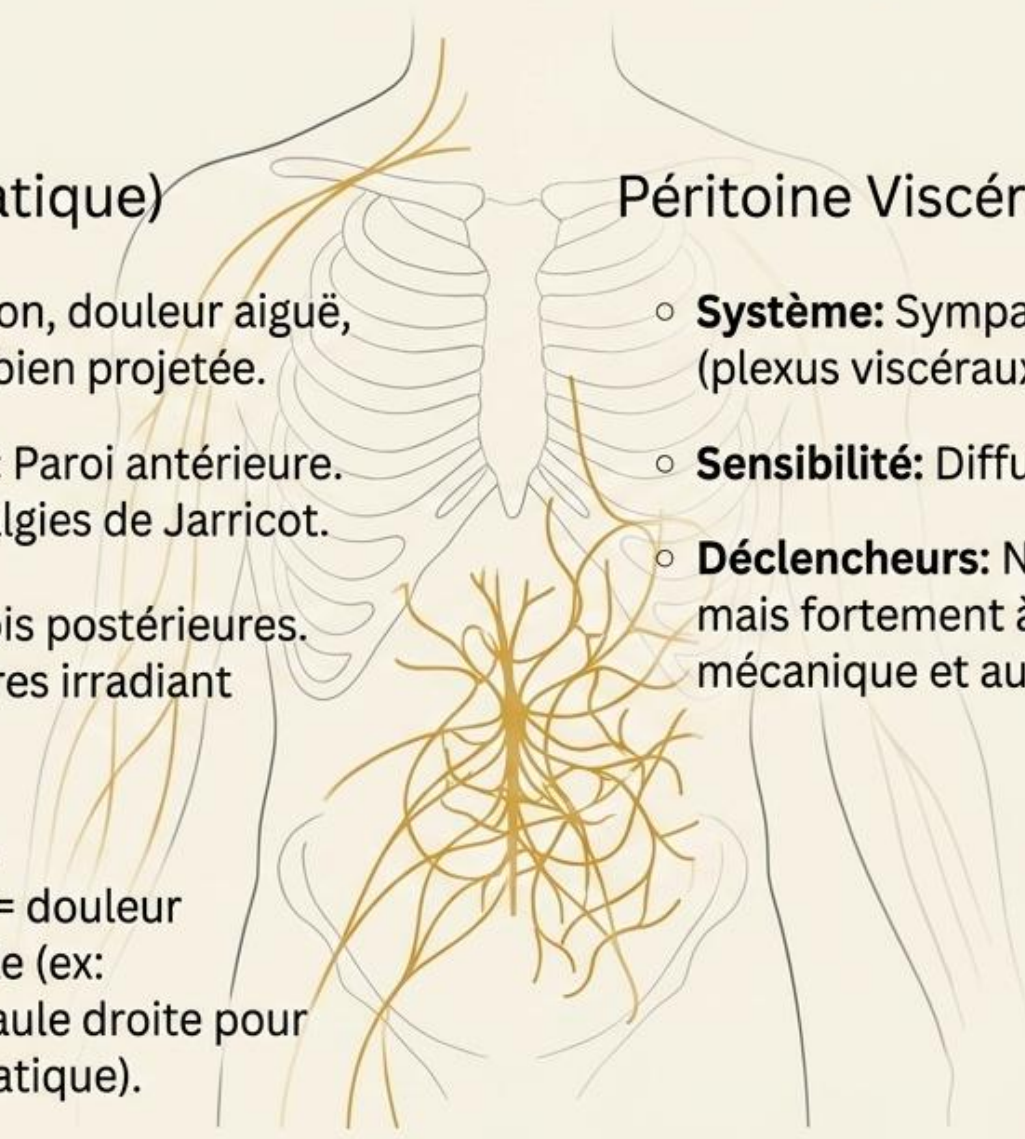
Double Réseau Nerveux : Somatique et Autonome

Péritoine Pariétal (Somatique)

- **Sensibilité:** Très fine (pression, douleur aiguë, thermique). Douleur locale bien projetée.
- **Nerfs Intercostaux (T7-T12):** Paroi antérieure. Lien clinique avec les dermalgies de Jarricot.
- **Plexus Lombal (L1-L4):** Parois postérieures. Irritation = douleurs lombaires irradiant vers l'aîne ou la cuisse.
- **Nerfs Phréniques:** Péritoine diaphragmatique. Irritation = douleur projetée scapulaire/cervicale (ex: scapulaire/cervicale (ex: épaule droite pour atteinte hépato-diaphragmatique)).

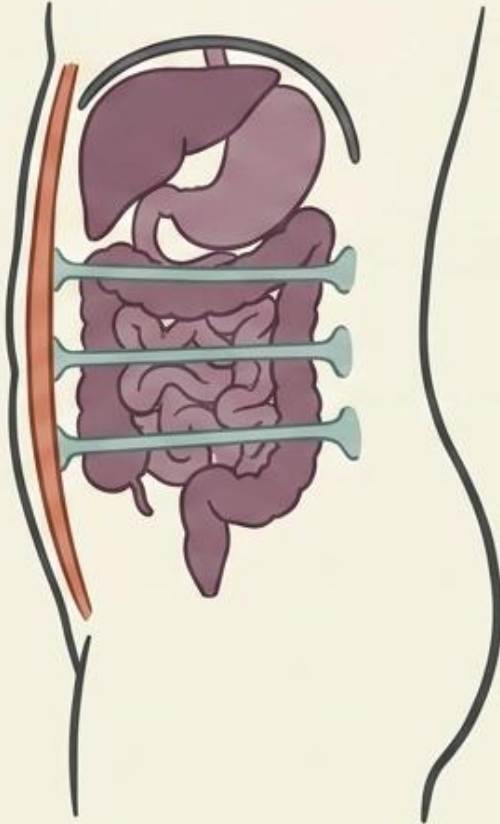
Péritoine Viscéral (Autonome)

- **Système:** Sympathique et Parasympathique (plexus viscéraux).
- **Sensibilité:** Diffuse et peu discriminative.
- **Déclencheurs:** Ne réagit pas au toucher fin, mais fortement à l'étirement, la distension mécanique et aux irritants chimiques.



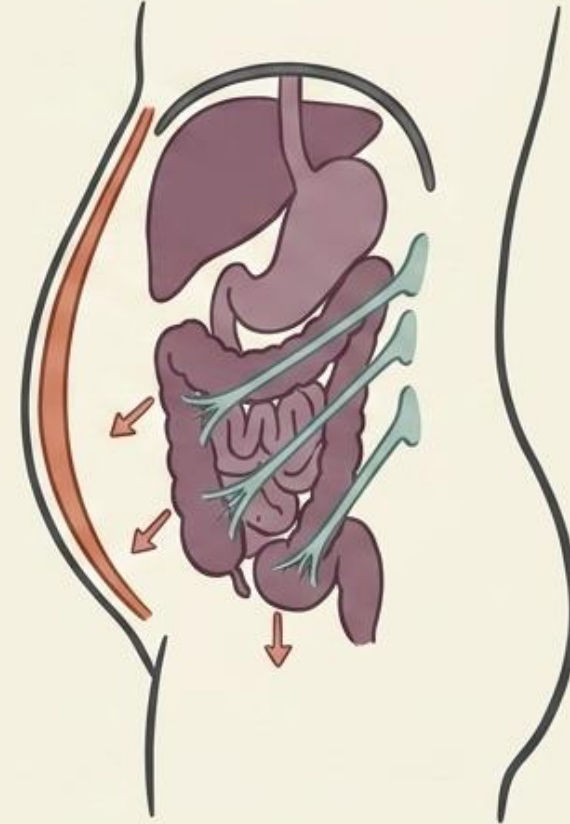
Physiologie Pariéto-Viscérale : Le Rôle du Transverse

Bonne Tonicité



- Maintien et cohésion des viscères abdominaux.
- Contre-force opposée au diaphragme lors des efforts (toux, accouchement).

Hypotonie de la Sangle (Lien ROP)



- Glissement caudal (descente) des viscères.
- Mise en tension et traction relative des mésos.
- Conséquence : Tensions pariéto-viscérales générant des réponses douloureuses ou musculaires.

Conséquences Mécaniques et Pathologies

Fixations et Adhérences

Séquelles chirurgicales ou inflammatoires.



Conséquence : Contrainte des vaisseaux, nerfs et viscères (risque d'occlusion).

Déficiences Pariétales

Modification des contraintes post-chirurgie.



Conséquence : Tiraillement des mésos, ptoses viscérales, hernies hiatales ou réductibles.

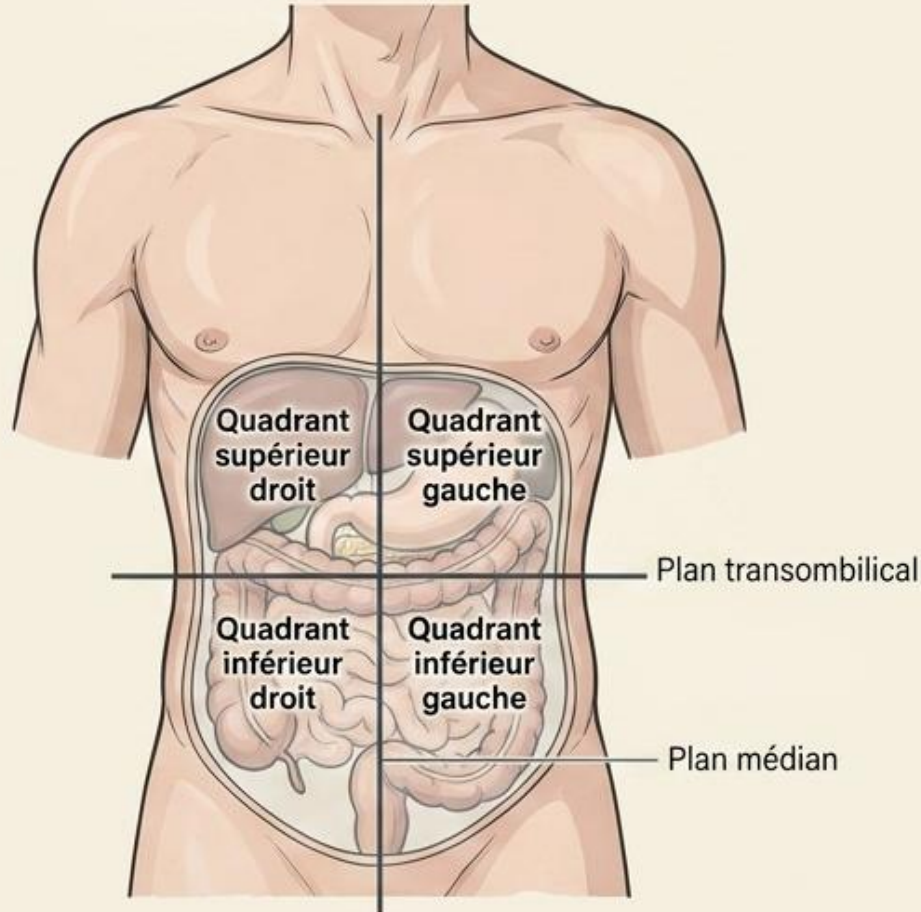
Gênes Fonctionnelles

Ex: Infertilité par séquelle d'appendicectomie.



Conséquence : Adhérences pelviennes réduisant la mobilité tubo-ovarienne (communication péritonéo-tubaire).

Synthèse Somatique : Les Quatre Quadrants



Principe : Le lien entre péritoine pariétal et système musculo-articulaire définit une cartographie clinique stricte.

Axe Sus-Ombilical : Pathologies viscérales projetant des douleurs vers les régions thoracique, cervicale, la tête et le membre supérieur homolatéral.

Axe Sous-Ombilical : Pathologies viscérales projetant des douleurs vers la région lombaire, le bassin et le membre inférieur homolatéral.

Cartographie des Douleurs Projetées

Quadrant Supérieur Droit



Scapulalgie et PSH droite (Origine : hépatique ou pulmonaire droite).

Quadrant Supérieur Gauche



Scapulalgie et PSH gauche (Origine : pulmonaire gauche, cardiaque ou stomacale).

Quadrants Inférieurs, Bilatéral



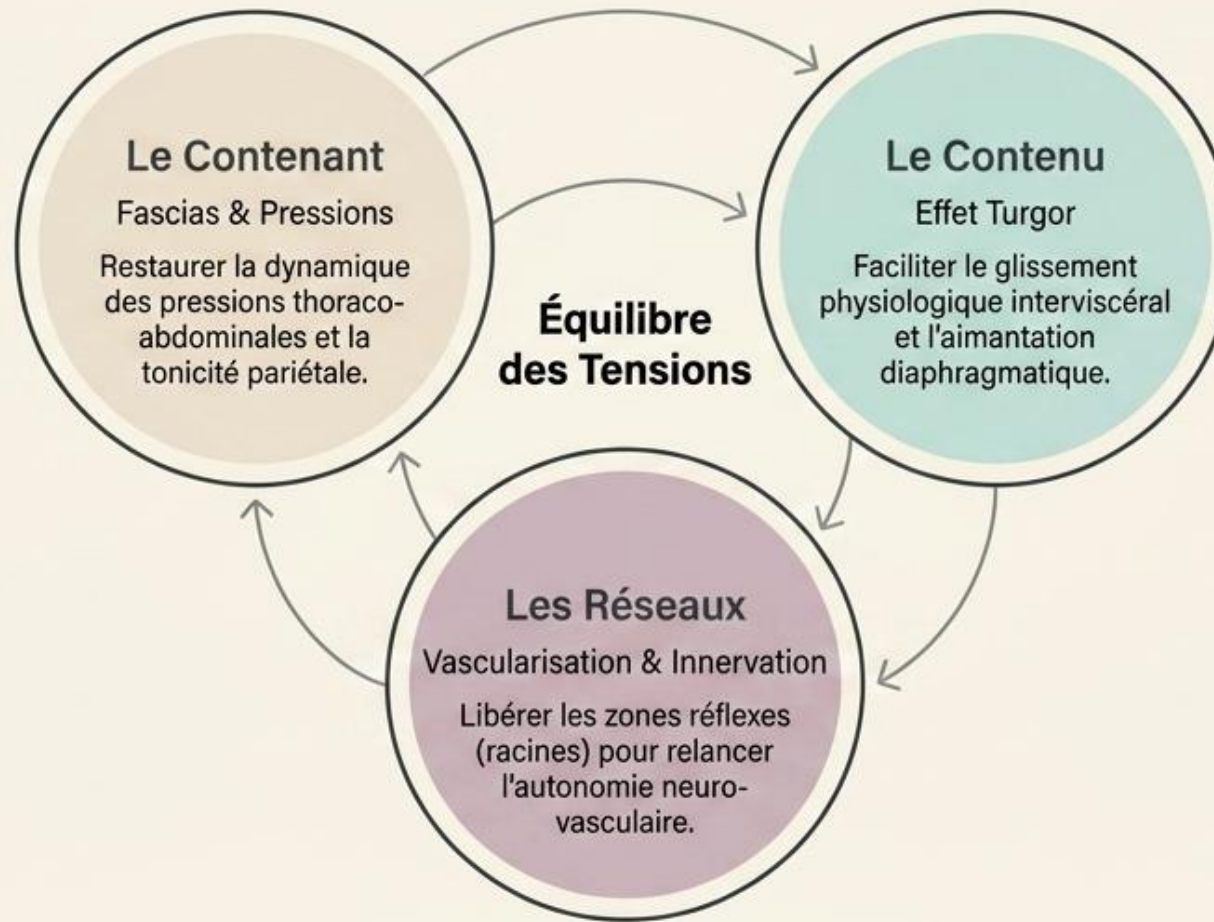
Cruralgie et lombalgie (Origine : dysfonction rénale homolatérale).



Sciatalgie (Origine : dysfonction uro-génitale homolatérale).

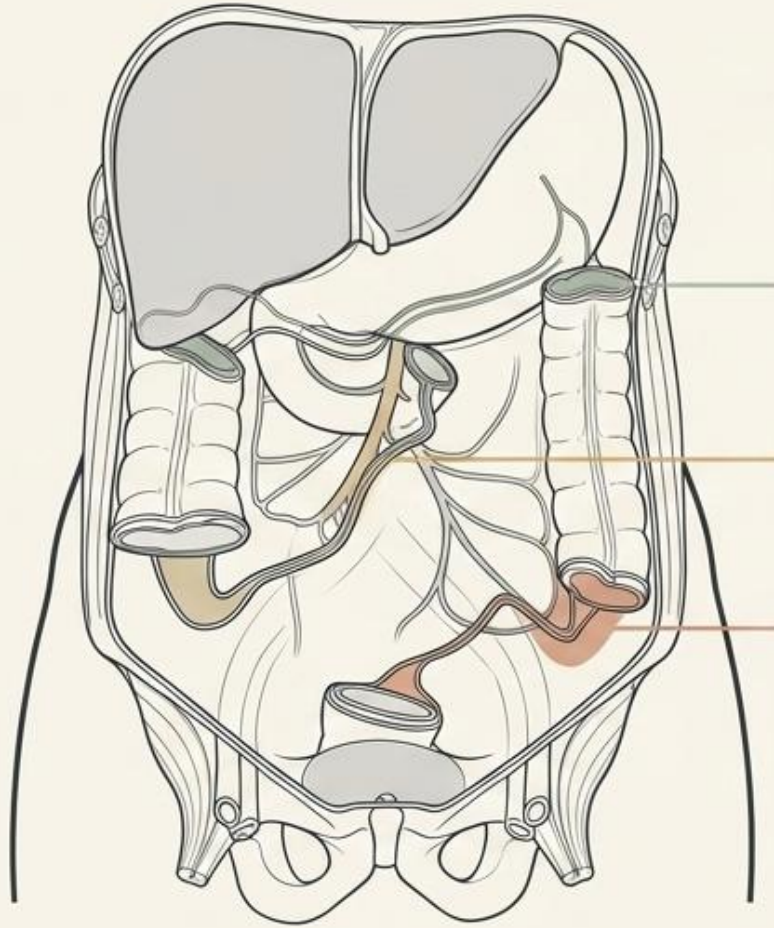
Douleur podale (Origine : rénale ou colique homolatérale).

L'Approche ROP : De l'Anatomie à l'Équilibre



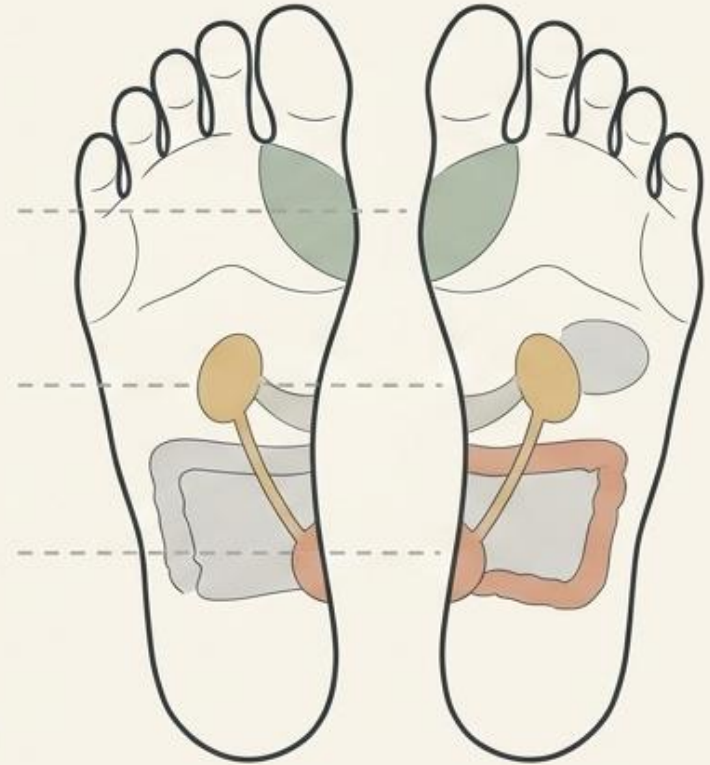
La pratique de la Réflexologie Occipito-Podale ne traite pas l'organe, mais informe le tissu de suspension pour permettre au système viscéral de retrouver son point d'homéostasie naturel.

Synthèse Clinique ROP : De l'Abdomen au Pied



Checklist

- 1. Lire les Tensions (Diagnostic) :**
Utiliser la topographie des 4 quadrants pour décoder les douleurs structurelles (membres/rachis) comme de potentiels signaux d'appel viscéraux.
- 2. Évaluer la Vitalité (Palpation) :**
Apprécier la souplesse des fascias, le pouls artériel, et la qualité de l'aimantation diaphragmatique.
- 3. Solliciter les Racines (Thérapeutique) :**
Agir via les zones réflexes podales spécifiques (Racine du mésentère, mésocolon transverse, mésosigmoïde) pour relâcher les amarres péritonéales et restaurer la mobilité.



La maîtrise de l'architecture péritonéale permet au praticien ROP de transformer un symptôme périphérique en une action viscérale ciblée et précise.